

Percorsi nelle Disabilità — Panoramica completa

Semestre 02 · 14 lezioni (tutte elaborate: 01–14)

Da Hammurabi alle politiche inclusive ticinesi del 2024, questo modulo costruisce uno sguardo completo sulla disabilità: prima la storia e le classificazioni, poi i quadri legali e i modelli interpretativi, poi le situazioni specifiche (deficit intellettivo, ASD, polyhandicap), la progettualità di vita e infine la famiglia come sistema di cura. Il filo rosso è sempre lo stesso: la disabilità non è nella persona — è nell'interazione tra la persona e un contesto più o meno ostile.

Mappa dei temi

#	Lezione	Tema centrale
01	Presentazione del modulo	Struttura del corso, Gardou, inclusione vs. integrazione
02	Disabilità nella storia — Parte 1	Dall'antichità ai pionieri dell'educazione speciale
03	Disabilità nella storia — Parte 2	Séguin, eugenismo, nazismo, dopoguerra
04	Convenzione ONU sui diritti (CDPD)	Quadro legale internazionale, Lingua Facile
05	Cambiamento dei concetti e modelli	ICD, ICIDH, ICF, PPH, 4 modelli istituzionali
06	ICF	Struttura dettagliata, codifica, facilitatori e barriere

#	Lezione	Tema centrale
07	Deficit Intellettivo	Criteri AAIDD, QI, comportamento adattivo, sostegni
08	ASD — Parte 1	Storia, diade diagnostica DSM-5, neurodiversità
09	ASD — Parte 2 e Polyhandicap	Intervento educativo, CAA, approcci; polyhandicap
10	Qualità di vita e progettualità	Meta-modello QdV, progetto di vita, assessment
11	Cicli di vita e autodeterminazione	Adulthood, liminalità, autonomia dipendente, Wehmeyer
12	LISPI e diritto di protezione	Piramide giuridica, curatela su misura, LISPI
13	Familiari curanti e siblings	Familiare curante, siblings, carichi, "dopo di noi"
14	Familiari — Pedagogia dei Genitori	Sapere familiare, narrazione, complementarità dei saperi

Evoluzione storica del concetto di disabilità

- **Antichità** → deficit = punizione divina o problema di sopravvivenza del gruppo
 - Infanticidio/esposizione accettati legalmente (Grecia, Roma)
 - **Ius vivendi** (Costantino, 274–337) → primo riconoscimento del diritto alla vita · (Lez. 02)
- **Mesopotamia** → modello magico; prima classificazione (mostri per eccesso/difetto/doppi, tavoletta 2800 a.C.) · (Lez. 02)

- **Medioevo** → "follia" come contenitore indifferenziato; visione dualistica Dio/Satana
 - **Grande Reclusione** → ospedali generali → segregazione ma anche prime risposte educative · (Lez. 02)
- **Fine '700 — Illuminismo** → Rivoluzione Francese → diritti dell'uomo → nasce la pedagogia speciale
 - **Pinel (1793)** → trattamento morale; toglie le catene agli alienati a Bicêtre
 - **Épée (1760)** → prima scuola pubblica per sordi
 - **Haüy (1784)** → prima scuola per ciechi; forma Louis Braille
 - **Esquirol (1818)** → prima distinzione scientifica disagio psichico ≠ deficit intellettivo
 - **Itard (1800–1801)** → 5 principi pedagogici (Victor dell'Aveyron) → "tutte le persone sono educabili"
 - **Séguin (1837–1839)** → prima scuola per persone con deficit intellettivo; rompe il fatalismo di Esquirol ("idioti sono quello che devono essere per tutta la vita"); programma fisico + intellettuale + morale; emigra negli USA nel 1851; contribuisce a fondare l'**AAMD** (oggi AAIDD) · (Lez. 02, 03)
- **Darwinismo sociale e eugenismo (fine '800 – inizio '900)** · (Lez. 03):
 - **Darwin (1859)** → premesse scientifiche (involontarie) per il ragionamento eugenista: frenare la riproduzione degli "esseri deboli"
 - **Galton (1880)** → fonda l'eugenismo: "migliorare la discendenza delle razze più dotate"; il talento è ereditario; povertà = deficit genetico
 - **Degenerescenza** → ideologia che associa deficit intellettivo, povertà e criminalità in un'unica "inferiorità biologica" (1885–1925)
 - **Eugenismo applicato** → segregazione in istituti (doppia funzione: proteggere i "normali" e "proteggere" gli anormali) · sterilizzazione (obbligatoria dal 1920) · controllo immigrazione
 - ⚠ Fino agli anni '60 nessuna voce si levò contro questi istituti disumani
- **Nazismo (anni '30–'45)** · (Lez. 03):
 - Eugenismo ribattezzato "**igiene razziale**"
 - **Binding e Hoche (1920)** → nozione di "esseri inutili": la persona deve giustificare il fatto di essere in vita

- **Triade infernale** → deficit intellettivo + povertà + deficienza morale; poi vagabondi, disoccupati, omosessuali
- **1939** → decreto di Hitler: "programma eutanasia" (Aktion T4) — sterminio sistematico di persone con disabilità
- **Dopoguerra** · (Lez. 03):
 - Le idee eugeniste non spariscono con il nazismo
 - L'istituzionalizzazione resta dominante fino alla metà degli anni '70 in USA e Europa
 - **Le associazioni di genitori** sono il motore del cambiamento — non i governi
- **Anni '70** → movimenti attivisti USA → prime norme antidiscriminazione; nascita associazioni (Atgabbes 1967, Fondazione Diamante 1978, LISPI 1979) · (Lez. 04)
- **Evoluzione terminologica** · (Lez. 05):

Periodo	Termine	Modello
Fine anni '70	Invalido	Riabilitazione
Fine anni '80	Handicappato	Integrazione
Fine anni '90	Persona disabile	Partecipazione
Dal 2000	Persona con disabilità	Inclusione come diritto

Modelli interpretativi della disabilità

- **Modello biomedico** → deficit individuale; riparare la persona
- **Modello funzionale/riabilitativo** → recupero delle capacità operative
- **Modello ambientale** → le barriere del contesto creano l'handicap
- **Modello civico / diritti umani** → esclusione = discriminazione; il sistema deve cambiare
- **Modello biopsicosociale (ICF/CDPD)** → disabilità = interazione persona ↔ ambiente · (Lez. 05, 06)

4 modelli istituzionali (Mainardi, 2010) · (Lez. 05)

Quadrante	Luogo	Attenzione	Nome
0	Speciale	Nessuna	Esclusione / Ghettizzazione
1	Speciale	Speciale	Segregazione
2	Ordinario	Speciale (eccezionale)	Integrazione
3	Ordinario	Normalmente speciale	Inclusione

- **Integrazione** → misura eccezionale per la persona specifica; la persona si adatta al sistema · (Lez. 01, 05)
- **Inclusione** → misure speciali normali a priori per tutti; il sistema si adatta · (Lez. 01, 05)
 - ⚠️ Rischi: banalizzazione del termine, inclusione senza risorse = ri-esclusione mascherata
 - È una direzione, non un traguardo raggiunto
 - ⚠️ In certi momenti la separazione è la risposta migliore alla qualità di vita della persona

Classificazioni e strumenti OMS

- **ICD** → classifica le malattie per eziologia/patologia/manifestazione clinica; modello medico · (Lez. 05)
- **ICIDH (1980)** → malattia → menomazione → disabilità → handicap
 - Critica: lineare, negativo, non considera abbastanza l'ambiente, non dinamico · (Lez. 05)
- **PPH** → handicap come risultato di interazione persona-ambiente (innovazione rispetto a ICIDH) · (Lez. 05)
- **ICF (OMS, 2001)** → classificazione attuale; modello biopsicosociale · (Lez. 05, 06)

ICF

└─ Parte 1: FUNZIONAMENTO E DISABILITÀ

	—	Funzioni corporee (8 domini – b)
	—	Strutture corporee (8 domini – s)
	—	Attività e Partecipazione (9 domini – d)
—		Parte 2: FATTORI CONTESTUALI
	—	Fattori ambientali (5 domini – e)
	—	Fattori personali (non classificati)

- **Capacità** → cosa la persona può fare in ambiente standard (caratteristica intrinseca)
- **Performance** → cosa la persona fa nel suo contesto reale (dipende dal contesto)
- **Facilitatore** (+) → fattore ambientale che migliora il funzionamento
- **Barriera** (.) → fattore ambientale che limita il funzionamento e amplifica la disabilità
- **ICF-CY (2007)** → versione per 0–18 anni
- Distinzioni qualificative: **menomazione** (disfunzione corporea) · **limitazione** (difficoltà nell'attività) · **restrizione** (problema nella partecipazione) · (Lez. 06)

Quadro legale e diritti

- **Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo (1948)** → radice di tutte le convenzioni · (Lez. 04)
- **CDPD – Convenzione ONU** (adottata 13.12.2006; in vigore 2008; ratifica CH 15.04.2014) · (Lez. 04)
 - **Slogan** → "Niente su di noi, senza di noi"
 - **50 articoli**; non introduce nuovi diritti, concretizza quelli universali per le persone con disabilità
 - Disabilità = interazione tra menomazioni e **barriere ambientali/comportamentali** (Preambolo, art. e)

Articolo	Tema
Art. 19	Vita indipendente e scelta del luogo di vita

Articolo	Tema
Art. 21	Accesso all'informazione nella forma comunicativa scelta
Art. 24	Educazione inclusiva a tutti i livelli
Art. 27	Lavoro inclusivo e non discriminatorio
Art. 29	Vita politica e autodeterminazione

- Svizzera **non ha aderito** al Protocollo Facoltativo → nessun ricorso individuale al Comitato ONU
- Valutazione ONU Svizzera → esito negativo su istruzione, lavoro, scelta residenza
- **Iniziativa per l'Inclusione** → 107.910 firme, settembre 2024 · (Lez. 04)

Lingua Facile · (Lez. 04, 05)

- Basi CDPD: Art. 9 (accessibilità) + Art. 21 (libertà di espressione e accesso all'informazione)
- In Svizzera: Pro Infirmis; Ticino: Fondazione Diamante; Canton TI (votazioni dal 2019), RSI (2025)
- Quadro TI: Mozione 1446 (2019), Art. 13a Cost. TI (2022)
- **Integrativa** se disponibile solo su richiesta | **Inclusiva** se adottata a priori per tutta la comunicazione pubblica · (Lez. 05)

Deficit Intellettivo (DI)

- **Definizione AAIDD (2022)** → limitazioni significative in funzionamento intellettuale + comportamento adattivo, con esordio prima dei 22 anni · (Lez. 07)
- **3 criteri diagnostici** (tutti e tre devono coesistere):
 - **A. Funzionamento intellettuale** → $QI < 70$ (≥ 2 DS sotto la media; test Wechsler, Stanford-Binet)

- **B. Comportamento adattivo** → ≥ 2 DS sotto la media in almeno 1 dei 3 domini (concettuale, sociale, pratico)
- **C. Età di esordio** → prima dei 22 anni
- **Terminologia** → "deficit intellettivo" (corretto); "ritardo mentale" (obsoleto, da non usare)
 - **Disabilità cognitiva** = cappello più ampio (include DI + DSA + ADHD + difficoltà percettive)
- **Prevalenza** → 1–1,5% della popolazione (DSM-5)
- **Eziologia** → 30–40% sconosciuta; cause note: alterazioni embrionali (30%), fattori perinatali (10%), ereditari (5%)
- **Classificazione** → per intensità del sostegno (più utile del solo QI):

Livello	QI indicativo	Sostegni
Gravissimo	0–20/25	Continuo
Grave	20/25–40/45	Estensivo
Medio-grave	40/45–55	Limitato
Lieve	55–70/75	Intermittente

- **Sistemi di sostegno efficaci (AAIDD)** → centrati sulla persona · completi · coordinati · orientati agli esiti · (Lez. 07)
 - **Sostegni naturali** → famiglia, amici, comunità, tecnologia assistiva
 - **Sostegni specialistici** → operatori sociali, terapisti, didattica speciale
 - **Scaffolding** (Wood, Bruner, Ross, 1976) → impalcatura di supporto che si toglie con la crescita
 - **ZSP (Vygotskij)** → calibrare i sostegni vicino ai bisogni attuali; aggiornare con l'evoluzione
 - **SIS** (Thompson et al., 2004) → strumento per misurare l'intensità dei sostegni necessari
-

Disturbi dello Spettro Autistico (ASD)

- **Definizione** → sindrome comportamentale da disordine del neurosviluppo biologicamente determinato; diagnosi comportamentale; esordio prima dei 3 anni · (Lez. 08)
- **Frase-chiave** → "L'autismo non si cura, si **educa**"
- **Prevalenza** → 1/36 USA · 1/77 Italia · ~80.000 CH; 4× più frequente nei maschi

Tappe storiche chiave · (Lez. 08)

- **Kanner (1943)** → "autismo precoce infantile" — 11 bambini; ipotesi innata
- **Bettelheim (anni '60)** → "madre frigorifero" → errore storico; le cause non sono psicogene
- **Wing (1983)** → triade + concetto di **spettro**
- **DSM-5 (2013)** → unica etichetta ASD + **diade diagnostica** + 3 livelli di gravità

Diade diagnostica DSM-5 · (Lez. 08)

- **A** → deficit comunicazione e interazione sociale:
 - A.1 deficit reciprocità socio-emotiva
 - A.2 deficit comportamenti comunicativi non verbali
 - A.3 deficit sviluppo e gestione relazioni
- **B** → pattern ristretti e ripetitivi:
 - B.1 stereotipie, ecolalia
 - B.2 insistenza nella sameness (routine rigide)
 - B.3 interessi ristretti e fissi
 - B.4 iper- o ipo-reattività sensoriale (SIRS/HYPO/HYPER/EP)
- **3 livelli di gravità** → 1 (supporto) · 2 (supporto sostanziale) · 3 (supporto molto sostanziale)
- **Neurodiversità** (Singer, anni '90) → variazione neurologica come naturale variabilità umana

- Regola: "**Hai visto una persona con ASD — ne hai vista solo una**"

Intervento educativo nell'ASD · (Lez. 09)

- **Analisi funzionale** → non la diagnosi, ma come la persona funziona nel suo contesto
 - Focus su: capacità residue e **potenzialità di sviluppo** (qui si costruiscono gli obiettivi)
- **Aree PEI** → abilità motorie · autonomie personali · apprendimenti scolastici · abilità sociali · comunicazione
- **CAA/PECS** → quando il verbale non è raggiungibile; prerequisiti della comunicazione: percezione, imitazione, attenzione condivisa, intento comunicativo
- Principi chiave: training strutturato e ripetuto da tutti · abbassare l'ansia prima del training · usare la motivazione intrinseca
- **Comportamenti problema** → hanno funzione comunicativa → sostituire, non sopprimere (valutazione funzionale)

Metodo	Autore	Principio
ABA	Skinner	Rinforzo comportamento in setting 1:1
TEACCH	Schopler (1972)	Struttura visiva + adattamento ambientale
ESDM (Denver)	Rogers e Dawson	Parent training + ABA + sviluppo; da 12 mesi
Approcci naturalistici	Koegel et al. (1979)	Iniziativa del bambino in contesti spontanei
CAA / PECS	—	Comunicazione simbolica alternativa
CBT	Ellis e Beck	Pensieri + emozioni + comportamenti

Polyhandicap · (Lez. 09)

- **Definizione** → deficit fisico importante + deficit intellettivo severo/profondo; causa: danno cerebrale grave e precoce (prima dei 3 anni)
 - **Effetto** → restrizione estrema di autonomia, percezione, espressione, relazione; evolve nel tempo
 - **Funzionamento intellettivo** → livello profondo; ≈ bebè 6 mesi; periodo senso-motorio Piaget (stadi 1–4)
 - **Comunicazione** → comprensione precede sempre la produzione
 - ⚠ "non produrre ≠ non capire" — errore grave da non fare mai
 - Canale principale: non verbale (sguardo, gesti minimi); **causalità elementare** come base per comunicare
 - **Salute** → polipatologie gravi evolutive; epilessia frequente; dolore in 4 forme; effetti a cascata dal deficit motorio
 - Cambiamenti di comportamento = possibile segnale di dolore fisico non comunicato
 - **Dimensione etica** → persona non verbale non può segnalare abusi → supervisione d'équipe fondamentale; mai soli con questa utenza
 - **Sostegni** → intensità massima; équipe pluridisciplinare; parent training in tutti i momenti chiave della vita
-

Qualità di Vita e Progettualità · (Lez. 10)

- **Cambio di paradigma** → da sguardo medico (persona = diagnosi; operatore prescrive) a sguardo bio-psico-sociale (operatore accompagna; focus su barriere e sostegni)
 - Base: ICF (OMS) + Convenzione ONU → transizione: cura della persona → cura dei contesti

- **Qualità di vita (OMS, 1995)** → percezione individuale della propria posizione nella vita in relazione a obiettivi, aspettative, standard, interessi; è **soggettiva, multidimensionale, misurabile**

- Doppio ruolo (Cottini, 2016): **macro-finalità** di ogni intervento + **strumento di valutazione**

Meta-modello Schalock e Verdugo (2006) • (Lez. 10)

3 fattori → 8 domini → indicatori

Fattore	Domini
Indipendenza	Sviluppo personale · Autodeterminazione
Partecipazione sociale	Relazioni interpersonali · Inclusione sociale · Diritti
Benessere	Emozionale · Fisico · Materiale

- **Indicatori oggettivi** → standard condivisi (es. piramide alimentare)
- **Indicatori soggettivi** → preferenze, vissuti personali — entrambi necessari
- **Dimensione ecologica (Cottini)** → microsistema (persona) · mesosistema (servizi) · macrosistema (politiche)
- **Ricerca Ticino (Geronimi/SUPSI, 2023)** → QdV buona in generale; domini critici: inclusione sociale e diritti; le variabili **ambientali** pesano più di quelle personali • (Lez. 10)

Progetto di vita • (Lez. 10)

- **Definizione** → progettazione globale che abbraccia tutta la traiettoria di vita
- **Punto di partenza** → desideri, sogni, aspirazioni della persona
- **Co-costruito** con: persona + famiglia + rete di riferimento
- **Non è il PEI/PSI** → li include e li coordina (i PEI/PSI sono tasselli, non devono contraddirsi)
- Deve essere scritto "a matita" (Lepri) → rivalutato e modificato continuamente

Assessment (valutazione iniziale) · (Lez. 10)

- **Scopo** → conoscere i desideri e confrontarli con la situazione attuale
 - **Sguardo ecologico** → persona nel suo contesto (in linea con ICF)
 - **"Modo di essere" di Rogers** → autenticità · accettazione incondizionata · empatia
 - **Rischio da evitare** → *services-led* (valuto in base ai servizi disponibili)
 - **Obiettivo** → *needs-led* (valuto in base ai bisogni reali)
-

Cicli di vita e Autodeterminazione · (Lez. 11)

Cicli di vita e adultità

- **Cicli di vita** → infanzia, adolescenza, adultità, vecchiaia: ogni persona attraversa queste traiettorie evolutive; il Progetto di Vita deve accompagnarle
- **Eterno bambino** (Lepri) → immagine dominante che storicamente ha negato l'adultità alle persone con disabilità
- **Adultità** → non dipende dall'età anagrafica; dipende dall'accesso a ruoli valorizzanti e dalla capacità decisionale
- **Liminalità** (Murphy) → stato di "terra di mezzo" tra due fasi della vita
 - Mancano i **riti di transizione** simbolici (patente, viaggi da soli, passaggio al settore adulti)
 - Rischio: sospensione duratura → la persona è adulta biologicamente ma non riconosciuta socialmente
- **3 condizioni per la transizione all'adultità (Lepri):**
 1. Accesso a ruoli valorizzanti tipici dell'età adulta
 2. Famiglie e agenzie educative credono nell'adultità possibile — il prima possibile
 3. Potenziamento di: **individuazione** (conoscenza di sé) · **autonomia dipendente** · **autodeterminazione**

Autonomia dipendente

- **Autonomia dipendente** (Morin) → l'autonomia si fonda sulle dipendenze dal contesto — vale per **tutti**
 - "Per essere autonomi bisogna essere dipendenti"
- **Visione individualistica** (sbagliata) → autonomia = fare tutto da soli → produce discriminazione
- **Visione sistemica** (corretta) → la persona è sempre in relazione con il contesto; l'autonomia dipende dall'interazione

Autodeterminazione (Wehmeyer)

- **Definizione** → possibilità di prendere decisioni secondo propri valori e obiettivi, senza interferenze esterne non giustificate, per aumentare il controllo sulla propria vita
- **Agente causale** → la persona agisce intenzionalmente per raggiungere obiettivi specifici (≠ agente passivo)
- **Costrutto multidimensionale** → si apprende e si allena lungo tutta la vita; non è innata

Le 4 componenti (Wehmeyer):

Componente	Contenuto chiave
Autonomia	Agire in accordo con propri valori; capacità di scelta; processo decisionale
Autoregolazione	Definire obiettivi, modificarli, monitorarsi, problem solving
Autorealizzazione	Conoscenza di sé (punti di forza e limiti); si acquisisce con l'esperienza
Empowerment	Senso di autoefficacia; fiducia nelle proprie possibilità di successo

Modello funzionale (Wehmeyer, 1999): - **Capacità** (dimensione individuale) + **Opportunità** (dimensione ambientale) → con **sostegni** lungo tutta la vita → **comportamento autodeterminato**

Errori che ostacolano l'autodeterminazione

- **Infantilizzazione** → trattare adulti come bambini (linguaggio, diminutivi, decisioni al posto loro)
- **Falsa partecipazione** → far scegliere sapendo che la scelta non sarà rispettata
- **Narcisismo professionale** → realizzare la propria visione credendo di promuovere quella dell'utente
- **Controllo eccessivo** → intervenire per paura propria, non per bisogno reale della persona
- **Vicinanza eccessiva** → crea dipendenza dalla relazione, non autonomia

Approccio ecologico

- **Tessitore di relazioni** (Nuzzo) → l'operatore lavora anche sui contesti (vicini, negozianti, istituzioni, reti informali), non solo sulla persona
- Il Progetto di Vita non si esaurisce dentro il servizio → il servizio è un crocevia, non un confine
- **Scaffolding** (Bruner/Vygotskij) → sostegno esperto che si ritira progressivamente man mano che la persona acquisisce competenze
- **Capability approach** (Sen) → benessere = capacità di trasformare risorse in realizzazioni nella direzione scelta dalla persona

Autodeterminazione e QdV

- **Autodeterminazione** è uno degli 8 domini del meta-modello Schalock e Verdugo · (Lez. 10, 11)
 - **Ricerca Lachapelle (2005)** → autodeterminazione e QdV soggettiva sono correlate; ma i livelli di autodeterminazione risultano sistematicamente più bassi nelle persone con disabilità
-

Quadro giuridico cantonale e diritto di protezione · (Lez. 12)

Piramide delle fonti giuridiche

- **Convenzione ONU disabilità** (ratificata CH 2014) → livello massimo
 - **CEDU** → Convenzione europea dei diritti dell'uomo (1950)
 - **Costituzione federale** (1999) → art. 35–36
 - **Codice civile** (1907) → art. 388–398
 - **LPMA / ROPMA / LISPI** → livello cantonale Ticino
- ⚠ Ogni strumento cantonale deve rispettare tutti i livelli superiori

Principi di ogni intervento (art. 36 Cost. / art. 389 CC)

- **Sussidiarietà** → intervenire solo se famiglia e servizi ordinari sono insufficienti
- **Proporzionalità** → misura calibrata allo scopo (temporale e materiale)
- **Adeguatezza** → solo le misure strettamente necessarie

Capacità di discernimento

- **Definizione** → capacità di agire ragionevolmente; ha due aspetti:
 - **Cognitivo** → capisco perché lo faccio
 - **Volitivo** → valuto le conseguenze
- ⚠ Non è binaria: si valuta per ogni singola decisione, non per la persona in generale
- **Verifica** → riformulazione, analisi pro/contro, valutazione dell'impatto, difesa dell'opinione

Curatela su misura ("vestito su misura")

- **Curatela di sostegno** → affianca senza sostituire — minima invasività
- **Curatela di rappresentanza** → agisce al posto della persona in ambiti definiti
- **Curatela di amministrazione dei beni** → gestione patrimoniale

- **Curatela di cooperazione** → certi atti richiedono il consenso del curatore
- **Combinazione** → più tipi insieme per rispondere ai bisogni reali
- **⚠ Curatela generale** → strumento in via d'estinzione; contraria alla Convenzione ONU art. 12
- Quattro ambiti: amministrativo · cura della persona · benessere · patrimoniale/giuridico

Diritti strettamente personali

- **Assoluti** → nessuna rappresentanza possibile (matrimonio, testamento, tatuaggi, donazione organi)
- **Relativi** → rappresentanza possibile solo in caso di incapacità di discernimento (cure mediche, fotografie)

Riforma 2013

Prima (fino al 01.01.2013)	Dopo (dal 01.01.2013)
Autorità parentale prolungata — minorenne a vita	Promozione dell'autodeterminazione
Genitori decidono tutto	Accompagnamento alla vita adulta

LISPI — Legge cantonale ticinese

- **Definizione** → Legge sull'integrazione sociale e professionale degli invalidi (Canton Ticino)
- **Strumento per** → inclusione · inserimento professionale · protezione · libertà di scelta
- **4 obiettivi (art. 4)** → terapia · educazione · socializzazione · lavoro creativo e remunerato
- **⚠** Il luogo di vita è uno strumento, non un obiettivo
- **Direttive 1/3/5** → standard qualitativi emanati dall'Ufficio invalidi

Dati di contesto · (Lez. 12)

- ~1,8M persone over 16 con handicap in Svizzera; 300.000 con limitazioni forti (UFS, 2024)
 - 109.000 persone sotto misura di protezione in Svizzera (ARP, 31.12.2024)
 - 1.396 persone ancora sotto curatela generale (ARP, 31.12.2023) — dato in calo ma ancora presente
-

Familiari curanti e siblings · (Lez. 13)

Ruolo della famiglia nel progetto di vita

- **Bronfenbrenner** → la famiglia è presente a tutti i livelli ecologici (micro → macro); garantisce continuità nei passaggi tra fasi che i servizi non riescono ad assicurare
- **Ruoli dei familiari** → fonte di informazione (esperti per esperienza) · co-costruttori del PI · promotori del progetto · risorsa o ostacolo (dipende dal sostegno ricevuto) · rappresentanti legali (curatela)
- **ICF** → i fattori personali non sono classificabili → la famiglia diventa fonte indispensabile di conoscenza

Il familiare curante

- **Definizione** → persona che presta regolarmente assistenza/sorveglianza/accompagnamento a titolo non professionale, rendendo possibile il mantenimento a domicilio
- 1 persona su 4 o 5 in Svizzera è familiare curante (inclusi minorenni)
- **Sostegni** → centri diurni · congedi (Legge federale 20.12.2019: max 3 giorni/evento, 10 giorni/anno) · AGI (Assegno Grandi Invalidi) · contributi cantonali

I siblings

- **Sibling** → fratello/sorella di persona con disabilità — relazione più lunga della vita; ~260.000 bambini siblings in Svizzera

- **Risposta tipica** → *"È semplicemente così"* → la disabilità è normalità, non eccezione
- **Aspetti positivi** → empatia · autonomia · maturità · forte legame affettivo · tendenza a professioni sociali
- **Carichi** → eccesso di responsabilità ("mini-genitore") · mancanza di attenzione genitoriale · isolamento · stigma · rinuncia ai propri bisogni
 - ⚠ Rischio nascosto: il sibling "bravo e adattato" sviluppa disturbi psichici cronici nel tempo
- **Inquietudine per il futuro** → "dopo di noi" — chi si occuperà del fratello/sorella?
- **Bisogni (Hochschule Luzern, 2021)** → tempo per sé · ascolto emotivo · spazio per i propri sentimenti · informazioni sulla disabilità · confronto con altri siblings
- ⚠ **I siblings sono familiari curanti invisibili** — il lavoro sociale deve riconoscerli come tali

3 dimensioni di lavoro coi siblings (Mengoni): 1. Con i siblings (gruppi, tutte le età) 2. Con i genitori (delega, riconoscimento del figlio sano) 3. Con i professionisti (lavorare coi siblings come con i genitori)

Pedagogia dei Genitori · (Lez. 14)

- **Fondatori** → Moletto, Zucchi (Italia, anni '90); in Ticino dal 2005 (Atgabbes)
- **Ambito** → qualsiasi contesto genitoriale, non solo disabilità; a SUPSI DEASS da oltre 15 anni
- **Scopo** → valorizzare il sapere familiare come complementare al sapere professionale

Cambio di paradigma

- **Vecchio paradigma** → positivismo: esperto autosufficiente; conoscenza oggettiva; emozioni escluse
- **Nuovo paradigma** → visione ecologica: persona = sistema di relazioni; sapere situato; emozione e razionalità unite

Riferimenti teorici

Autore	Contributo
Feyerabend	Metafora contadino/agronomo: il genitore ha il sapere concreto del proprio figlio; l'agronomo (professionista) ha quello comparativo → complementarietà, non gerarchia
Vygotskij	L'uomo è cultura, storia, rete di relazioni
Bruner	Pedagogia popolare — il sapere familiare ha valore scientifico
Vico	"verum ipsum factum" — si conosce solo ciò che si fa direttamente
Schoen	Professionista riflessivo — impara dall'azione e dai partner
Kuhn	La scienza avanza per rivoluzioni di paradigma

- ⚠ Il genitore è esperto del **proprio** figlio — non della diagnosi in generale

Narrazione — strumento centrale

- **Narrazione** → dare forma all'esperienza per renderla comunicabile e condivisibile
- Due livelli: **cognitivo** (consapevolezza delle scelte educative) + **emotivo** (costruzione di comunità)
- **Regola fondamentale** → si narra sempre dal positivo
- **Gruppo di narrazione** → spazio periodico; genitori + professionisti narrano insieme
- **"Con i nostri occhi"** → il genitore presenta il figlio nella sua totalità (non la diagnosi)
- Narrazioni pubblicate → cittadinanza attiva, cambio culturale

Sei valori pedagogici in azione

Valore	Significato breve
Responsabilità	Accompagnamento genitoriale per tutta la vita
Identità e riconoscimento	Il figlio si costruisce nell'essere visto come unico
Speranza	Senza speranza non esiste progetto di vita
Fiducia	Valorizzare le potenzialità → autonomia progressiva
Crescita	Lungo durata: flessibilità + argini solidi
Inadeguatezza	Sentirsi inadeguati = adattamento continuo (risorsa, non limite)

Formazione narrativa vs. informazione

- **Informazione** → fornisce notizie ma non modifica gli atteggiamenti
- **Formazione narrativa** → cambiamento durevole di pensiero e comportamento
- Condizione: cornice teorica epistemologica **prima** della narrazione (senza teoria → emozione evapora; senza narrazione → teoria rimane fredda)

Genitori come formatori

- Una delle azioni centrali di Atgabbes → genitori entrano nelle scuole (SUPSI, DEASS) come formatori con narrazioni scritte
- Non sono "casi" — sono esperti che formano i futuri professionisti

Termini e linguaggio rispettoso • (Lez. 05)

- **Regola SUPSI** → persona prima del deficit: "persona con disabilità" (non "disabile" come sostantivo)

- **Da evitare** → invalido, handicappato, diversamente abile, portatore di handicap
- **Motivazione** → sostantivare riduce la persona al deficit

Autori e riferimenti principali

Chi	Contributo	Lezione
Charles Gardou	<i>Nessuna vita è minuscola</i> (2016); 5 assiomi; "Terza nazione del mondo"	01, 05
Jean-Luc Nancy	Concetto di "singolari plurali"	01
Jürgen Habermas	Agire strumentale vs. comunicativo	01
Philippe Pinel	Trattamento morale; toglie le catene a Bicêtre (1793)	02
Jean-Marc Itard	5 principi pedagogici; Victor dell'Aveyron; padre pedagogia speciale	02
Esquirol	Prima classificazione scientifica: idiozia, imbecillità, demenza (1818)	02
Abbé de l'Épée	Prima scuola pubblica per sordi (1760)	02
Valentin Haüy	Prima scuola per ciechi; forma Braille (1784)	02
Édouard Séguin	Prima scuola per idioti (1839); "Trattamento morale degli idioti" (1846); co-fondatore AAMD	02, 03
Charles Darwin	"L'origine della specie" (1859); premesse per il darwinismo sociale	03
Francis Galton	Fonda l'eugenismo (1880); il talento è ereditario; povertà = deficit genetico	03
Binding e Hoche		03

Chi	Contributo	Lezione
	Nozione di "esseri inutili" (1920); la persona deve giustificare l'esistenza	
Hitler / Reich	"Programma eutanasia" Aktion T4 (1939) — sterminio persone con disabilità	03
Marco Paolini	"Ausmerzen – Vite indegne di essere vissute" — documentazione teatrale Aktion T4	03
OMS	ICD, ICIDH (1980), ICF (2001), ICF-CY (2007)	05, 06
Mainardi	4 modelli istituzionali (esclusione, segregazione, integrazione, inclusione)	05
ONU	CDPD — adottata 2006; ratifica CH 2014	04
AAIDD	Definizione DI + sistemi di sostegno (2022)	07
Binet + Simon	Prima scala di intelligenza (1905)	07
Vygotskij	Zona di Sviluppo Prossimale	07
Wood, Bruner, Ross	Scaffolding (1976)	07
Leo Kanner	"Autismo precoce infantile" (1943)	08
Lorna Wing	Triade + concetto di spettro (1983)	08
DSM-5	Diade diagnostica ASD + 3 livelli di gravità (2013)	08
Schopler	TEACCH (1972)	09
Rogers e Dawson	ESDM / Modello Denver	09
Halliday	7 funzioni linguistiche (1975–1980)	09

Chi	Contributo	Lezione
Schalock e Verdugo	Meta-modello QdV: 3 fattori, 8 domini (2006)	10
Cottini	QdV come macro-finalità e strumento; ecologia (micro/meso/macro)	10
Geronimi / SUPSI	Ricerca QdV in Ticino (2023)	10
Pro Infirmis / Fondazione Diamante	Lingua facile in Svizzera e Ticino	04
Wehmeyer	Definizione e modello funzionale di autodeterminazione (4 componenti)	11
Murphy, R.F.	Concetto di liminalità (<i>Il silenzio del corpo</i> , Erickson 2017)	11
Lepri, C.	Adulthood nelle persone con disabilità intellettiva; "eterno bambino"; 3 condizioni	11
Morin, E.	Autonomia dipendente	11
Nuzzo, A.	Operatore come "tessitore di relazioni"	11
Sen, A.	Capability approach (1993)	11
Judith Singer	Concetto di neurodiversità (anni '90)	08
Lachapelle et al.	Correlazione autodeterminazione-QdV soggettiva (2005)	11
Ersilia Gianella	Docente-ricercatrice SUPSI — diritto di protezione e LISPI	12
LISPI	Legge cantonale TI sull'integrazione sociale e professionale degli invalidi	12
Bronfenbrenner		13

Chi	Contributo	Lezione
	Ecologia dello sviluppo — famiglia a tutti i livelli	
Hochschule Luzern	Studio quantitativo siblings (265 persone, 2021)	13
Mengoni	3 dimensioni di lavoro coi siblings	13
Atgabbes	Associazione famiglie TI; Photovoice Siblings Ticino; Pedagogia dei Genitori in TI dal 2005	04, 13, 14
Moletto & Zucchi	Fondatori Pedagogia dei Genitori (Italia, anni '90)	14
Feyerabend	Metafora contadino/agronomo — complementarità sapere familiare e professionale	14
Schoen	Professionista riflessivo	14

Parole chiave della materia

disabilità · handicap · deficit · menomazione · inclusione · integrazione · segregazione · esclusione · grande reclusione · trattamento morale · ius vivendi · eugenismo · darwinismo sociale · degenerescenza · igiene razziale · esseri inutili · Aktion T4 · triade infernale · sterilizzazione · AAMD · ICD · ICIDH · ICF · ICF-CY · PPH · modello biomedico · modello biopsicosociale · facilitatore · barriera · capacità · performance · CDPD · "niente su di noi senza di noi" · Lingua Facile · art. 19 · autodeterminazione · QI · comportamento adattivo · scaffolding · ZSP · SIS · deficit intellettivo · disabilità cognitiva · ASD · diade diagnostica · spettro · neurodiversità · sameness · ecolalia · CAA · PECS · ABA · TEACCH · ESDM · PEI · analisi funzionale · parent training · polyhandicap ·

causalità elementare · QdV · meta-modello · progetto di vita · assessment · needs-led · services-led · microsistema · mesosistema · macrosistema · Atgabbes · Pro Infirmis · LISPI · Fondazione ARES · singolari plurali · cicli di vita · aduttità · liminalità · eterno bambino · riti di transizione · autonomia dipendente · agente causale · modello funzionale · empowerment · autoregolazione · autorealizzazione · infantilizzazione · tessitore di relazioni · approccio ecologico · capability approach · self advocacy · curatela su misura · curatela generale · curatela di sostegno · curatela di rappresentanza · capacità di discernimento · sussidiarietà · proporzionalità · adeguatezza · ARP · autorità parentale prolungata · diritti strettamente personali · piramide delle fonti giuridiche · familiare curante · sibling · dopo di noi · AGI · esperti per esperienza · IMAGENCY · ambivalenza · pedagogia dei genitori · sapere dell'esperienza · narrazione · complementarità dei saperi · gruppo di narrazione · formazione narrativa · professionista riflessivo · cambio di paradigma · comunità educante · speranza · inadeguatezza

Filo conduttore

Il modulo percorre una trasformazione radicale nel modo in cui la società pensa alle persone con disabilità: da oggetti di paura, pietà o curiosità a soggetti di diritto. Questa traiettoria attraversa la storia (dall'infanticidio greco ai pionieri dell'educazione speciale; dalla svolta di Séguin fino all'orrore dell'eugenismo e del nazismo, con il programma eutanasia Aktion T4 del 1939 — uno degli episodi più bui della storia occidentale, figlio diretto di quella stessa ideologia della degenerescenza che aveva trasformato la scienza in strumento di eliminazione), i modelli teorici (dal biomedico al biopsicosociale), il diritto internazionale (CDPD 2006) e gli strumenti clinico-educativi (ICF, PEI, analisi funzionale). Il percorso arriva fino alle norme cantonali ticinesi (LISPI, diritto di protezione) e alla famiglia come sistema di cura spesso invisibile — dai genitori, ai siblings, fino alla Pedagogia dei Genitori che riconosce il sapere familiare come complementare, non

subordinato, a quello professionale. Tutto converge su un'unica domanda: cosa rende buona la vita di una persona con disabilità? La risposta è sempre ambientale prima che individuale: le variabili contestuali pesano più di quelle personali (Geronimi/SUPSI, 2023). L'inclusione non è un traguardo raggiunto — è un **orizzonte** verso cui orientare ogni scelta professionale, sapendo che la disabilità non abita nella persona, ma nello spazio tra la persona e un contesto che non sa ancora accoglierla.

Domande di orientamento allo studio

Come è cambiato nel corso dei secoli il modo in cui la società trattava le persone con disabilità? Quali sono le tappe più significative? Il percorso va dall'eliminazione fisica alla partecipazione come diritto. Nell'antichità, le persone con disabilità grave venivano eliminate (infanticidio, esposizione) — pratica accettata fino ai primi imperatori cristiani, che sancirono lo *ius vivendi* (Costantino, 274–337). Nel Medioevo, la "follia" raccoglieva tutti i "diversi" in un contenitore indifferenziato, che sfocia nella Grande Reclusione. La svolta arriva con l'Illuminismo: Pinel umanizza il trattamento, Itard dimostra che tutte le persone sono educabili, Esquirol separa disagio psichico da deficit intellettuale. Séguin apre la prima scuola per idioti nel 1839, ma questa traiettoria positiva viene interrotta dall'eugenismo (Galton, 1880) e dalla sua radicalizzazione nazista: il programma eutanasia (Aktion T4, 1939) porta allo sterminio sistematico di persone con disabilità. Il dopoguerra non cancella subito il modello istituzionale — fino agli anni '70 la segregazione resta dominante. La svolta viene dalle associazioni di genitori, poi dalla CDPD del 2006 come sintesi di un cambio culturale globale. (Lez. 01, 02, 03, 04, 08)

Qual è il collegamento tra il modello biopsicosociale dell'ICF e la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità (CDPD)?

Entrambi condividono la stessa definizione di disabilità: non è una caratteristica della persona, ma il risultato dell'interazione tra la persona con menomazioni e le barriere del contesto. L'ICF (OMS, 2001) traduce questo principio in uno strumento di classificazione del funzionamento — si chiede cosa la persona può fare nel suo contesto. La CDPD (2006) lo traduce in diritti giuridici: è il contesto che deve

adattarsi, non la persona. I due strumenti sono complementari: l'ICF è lo strumento clinico-educativo, la CDPD è il quadro di diritti che ne giustifica l'uso. Entrambi portano alla stessa implicazione pratica: l'operatore sociale lavora sull'ambiente, non (solo) sulla persona. (Lez. 04, 05, 06)

Come si distinguono integrazione e inclusione, e perché questa distinzione è fondamentale nella pratica professionale? Nell'integrazione, la persona con disabilità entra in contesti ordinari con misure speciali eccezionali negoziate caso per caso — è la persona che si adatta al sistema. Nell'inclusione, le misure speciali diventano la norma per tutta la popolazione, a priori — è il sistema che si adatta a tutti. Per la pratica professionale, agire in ottica inclusiva significa progettare il contesto per tutti (rampe ovunque a priori), non solo rispondere a emergenze individuali. Due attenzioni: l'inclusione non è una scala del bene e del male (a volte la separazione è la risposta migliore alla qualità di vita), e l'inclusione senza risorse di sostegno porta alla ri-esclusione mascherata nel tempo. (Lez. 01, 05)

Qual è il percorso evolutivo delle classificazioni OMS dalla ICD alla ICF? Cosa ha cambiato concettualmente ciascuna tappa? L'ICD classifica le malattie per cause: sguardo medico, non considera le conseguenze nella vita. L'ICIDH (1980) guarda alle conseguenze della malattia con la sequenza menomazione → disabilità → handicap — ma è lineare, negativa e sottovaluta i fattori ambientali. Il PPH anticipa la logica dell'interazione: l'handicap emerge dall'incontro tra fattori personali e ambientali. L'ICF (2001) sintetizza tutto: classifica il funzionamento della persona nel suo contesto, si chiede cosa la persona può fare, e introduce esplicitamente barriere e facilitatori. È il passaggio definitivo dal deficit al funzionamento. (Lez. 05, 06)

Cosa accomuna il deficit intellettivo, l'ASD e il polyhandicap nella loro presa in carico educativa? Tutte e tre le condizioni richiedono: (1) un'analisi funzionale concreta — non limitarsi alla diagnosi ma capire come quella persona funziona nel suo contesto; (2) l'individuazione di barriere e facilitatori (ICF); (3) sostegni calibrati sui bisogni reali (scaffolding e ZSP di Vygotskij); (4) obiettivi che partono dai punti di forza e dalle potenzialità; (5) continuità e coerenza tra tutti gli attori. La differenza è nell'intensità: il DI varia molto tra lieve e gravissimo; l'ASD richiede strutturazione dell'ambiente e lavoro sulla comunicazione; il polyhandicap

richiede l'intensità massima e una supervisione d'équipe rigida per i rischi etici.
(Lez. 07, 08, 09)

Come si collega il paradigma della qualità di vita a tutto il percorso del modulo? La qualità di vita (QdV) è l'orizzonte verso cui convergono tutti i concetti studiati. Il modello biopsicosociale (ICF) dà le categorie per valutare il funzionamento. La CDPD garantisce i diritti. I sistemi di sostegno (DI, ASD, polyhandicap) sono i mezzi. Il progetto di vita è lo strumento operativo. E la QdV (meta-modello Schalock e Verdugo, 2006) è il criterio di valutazione finale: l'intervento funziona se migliora la vita reale della persona nei suoi otto domini. Come rileva la ricerca ticinese (Geronimi/SUPSI, 2023), le variabili ambientali pesano più di quelle personali — il che significa che l'operatore può davvero fare la differenza. (Lez. 05, 06, 07, 09, 10)

Come si traduce il principio di autodeterminazione nel diritto di protezione svizzero e nella LISPI? Il principio di autodeterminazione, affermato dalla CDPD (art. 12 e 19) e teorizzato da Wehmeyer come costruito a 4 componenti, ha trovato espressione concreta nella riforma del Codice civile del 01.01.2013: l'autorità parentale prolungata è stata abolita, sostituita da un sistema di curatela su misura (logica del "vestito su misura"). I tre principi di ogni intervento (sussidiarietà, proporzionalità, adeguatezza) traducono direttamente la logica ONU: intervenire solo se necessario, solo quanto necessario, solo per quanto necessario. La curatela generale — la misura più invasiva — è ancora presente (1.396 casi al 31.12.2023) ma contraria alla CDPD art. 12 e in via d'estinzione. La LISPI, a livello ticinese, opera nello stesso spirito: il luogo di vita è uno strumento, non un obiettivo. (Lez. 04, 11, 12)

Qual è il ruolo della famiglia — in particolare dei siblings — nel lavoro educativo e sociale, e cosa aggiunge la Pedagogia dei Genitori? La famiglia è presente a tutti i livelli ecologici (Bronfenbrenner) e garantisce continuità nei passaggi tra le fasi della vita che i servizi non assicurano. I siblings sono i familiari curanti più invisibili: la relazione fraterna è la più lunga della vita, ma viene sistematicamente ignorata. Lo studio della Hochschule Luzern (2021) mostra che i bisogni principali dei siblings sono ascolto emotivo, spazio per i propri sentimenti e informazioni sulla disabilità. Il rischio: il sibling "bravo e adattato" sviluppa disturbi psichici cronici nel tempo se rimane senza sostegno. La Pedagogia dei Genitori

(Moletto e Zucchi, anni '90; Ticino dal 2005) aggiunge una dimensione epistemologica: il genitore possiede un sapere sull'esperienza concreta del proprio figlio che nessun professionista può replicare — il genitore è l'agronomo che non si può sostituire, ma integrare. Questo cambia il tipo di relazione tra operatore e famiglia: non più esperto vs. paziente, ma due saperi complementari co-costruttori del progetto di vita. (Lez. 13, 14)

Qual è il filo conduttore dell'intera materia "Percorsi nelle Disabilità"?

Il filo conduttore è il passaggio da un paradigma dove la disabilità abita nella persona a uno dove la disabilità emerge dalla relazione tra la persona e un contesto più o meno ostile. Questo attraversa tutto il modulo: storicamente (dall'infanticidio alla pedagogia speciale), concettualmente (dal modello medico al biopsicosociale), giuridicamente (dalla carità alla CDPD), strumentalmente (da diagnosi = destino a analisi funzionale + progetto di vita), e socialmente (dal singolo alla famiglia, fino ai siblings e alla Pedagogia dei Genitori che riconosce il sapere familiare come sapere scientifico). Il risultato pratico per chi lavora nel settore è uno solo: l'intervento professionale si focalizza sull'ambiente e sui sostegni, non sulla "correzione" della persona — e lo fa in alleanza con la famiglia, non al suo posto. L'inclusione è la direzione, la qualità di vita è la misura, e la persona — con i suoi desideri, sogni e aspirazioni — è sempre il punto di partenza.